DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2024.06.004

# 创新药医保谈判的博弈分析

谭清立[1,2],李永盈[1],崔洪瑞[1]

【摘　要】博弈分析发现,随着国家基本医保药品目录调整常态化,医保谈判规则逐渐明晰,医保部门与医药企业之间的博弈不断"升级"。医保谈判药品存在量价不平衡现象,导致医药企业对创新药进入医保的积极性降低。为此,要增加医保基金对高值药品的支出,减少额外的资源配置成本;通过构建有效的激励约束机制、多方共同参与的监督约束机制,提高医保谈判决策的科学性,推动医保谈判药品成功落地。

【关键词】创新药;国家基本医保药品目录;医保谈判;博弈论

中图分类号:R19　　文献标识码:A　　文章编号:1004-7778(2024)06-0005-06

**Game Analysis of Health Insurance Negotiation for Innovative Drug**

TAN Qingli, LI Yongying, CUI Hongrui

**Abstract:** With the normalization of the adjustment of the national basic health insurance drug catalog, the rules of health insurance negotiation are gradually clarified, and the game between the health insurance department and the pharmaceutical enterprises is constantly "upgraded". There is an imbalance between the quantity and price of medicines negotiated by the health insurance, which leads to a decrease in the enthusiasm of pharmaceutical companies for innovative drugs to enter health insurance. In this regard, it is necessary to increase the expenditure of the health insurance fund on high-value medicines, reduce the additional resource allocation costs, improve the scientific nature of the decision-making of the health insurance negotiation through the construction of an effective incentive and constraint mechanism and the supervision and constraint mechanism with the participation of many parties, so as to promote the successful landing of the negotiated medicines.

**Key words:** innovative drugs; national basic health insurance drug catalog; health insurance negotiation; game theory

**First-author's address:** School of Medical Business, Guangdong Pharmaceutical University, Zhongshan Guangdong 528453, China

近年来,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》调整进入常态化,医保谈判规则逐渐明晰。医保谈判成为药品放量的重要催化剂,是衔接创新药研发和商业化的重要一环[1-4]。对创新药来说,既是机遇,又是挑战[5,6]。本文基于博弈论、委托代理理论和利益相关者理论,通过构建医药企业与医保部门之间的不完全信息非合作博弈模型,对创新药进入医保谈判的相关利益主体,以及博弈行为、博弈均衡点进行分析,针对实践存在的问题提出可行的改进路径,以期实现医药企业、政府部门、患者的多方共赢。

## 1 创新药是否进入医保的博弈

博弈各方由于期望偏好不同,做出的策略选择也会不同,即:可能合作,也可能不合作。因此在推动医保谈判形成科学合理的药品价格时,要兼顾各方合理化、差异化的利益诉求,使各方朝着一致的目标展开合作。

### 1.1 创新药医保谈判过程的多元主体

(1)医药企业。作为药品提供方,医药企业为了追求自身利益最大化,会尽量降低成本,提高药品价格,扩大利润空间。新医改前,医药企业实际的成本组成包括研发成本、生产成本、销售成本、流通成本、资金成本和税费。实行药品集中带量采购和医保谈判后,医药企业通过"以量换价",占据了更大的市场份额,药品的单位生产成本和非生产性费用有所减少,虽然价格下降,利润反而有所增长。例如国内首个上市的P-CAB药物——富马酸伏诺拉生片,在进入医保后快速放量,据米内网数据,其在重点省市公立医院终端销售额由2021年的0.7亿元增长至2022年的1.7亿元,增速达135.28%。还有石药集团的丁苯酞氯化钠注射液、阿斯利康的醋酸戈舍瑞林缓释植入剂等药品,在进入医保后,销售额连续取得

1.广东药科大学医药商学院,广东 中山 528453
2.广东药科大学卫生经济与健康促进研究中心,广东 广州 510308
**基金项目:**2024年度广东省哲学社会科学规划一般项目"价值医疗导向下中西医协同广东实践与长效机制的构建"(GD24CGL29)。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

突破性增长。

(2)医保部门。医保部门是药品支付方,是患者的委托代理方,其目标是用有限的基金支付使参保患者获得更高质量的医疗服务和更加合理的药品价格。医保部门关注医保基金的使用效率,并在合理控费的前提下,尽力保障参保患者的用药需求,加大对创新药的支出,“把钱花在刀刃上”。同时,医保谈判制度及配套政策设计会充分考虑药品种类、药物临床价值等因素,适时调整谈判规则,推动谈判成功及谈判成功后的落实。

(3)患者。患者作为药品使用方,有着获得优质药品、降低药品价格、减少医药支出的诉求。由于医药企业拥有一定的垄断地位,患者对药品价格的制约作用并不明显,但随着医保覆盖范围的扩大和参保患者的增多,医保部门在医保谈判过程中拥有更为强势的谈判地位和议价能力,能够促使医药企业降低药品价格,满足患者诉求。

1.2 医药企业与医保部门的博弈模型构建

医保谈判的重点在于解决药品供应方追求最大利润和需求方期望获得“质优价廉”药品之间的矛盾。根据委托代理理论,医保部门代表参保患者利益,因此本文主要针对医药企业和医保部门两大利益主体构建不完全信息博弈模型。

(1)政府(医保部门)发出谈判声明,企业自主申报参与遴选,并提供药品相关信息作为定价依据,政府(医保部门)通过基金测算、药物经济学评估,对通过遴选的药物确定“密封底价”(假设这一价格已综合考量多方面因素)。

(2)谈判过程中,“密封底价”是医保方谈判的底牌,同时也是医药企业报价的“靶心”,按照谈判规则,医药企业先行报价并且有两次报价机会,如果第二次确认后的价格高于医保方谈判底价的115%,谈判失败并自动终止;反之,报价在谈判底价的115%范围内,进入磋商阶段。

(3)医药企业在整个医保谈判过程中可以做出选择:要么降价进入医保(以价换量),利润有一定的增长空间[7];要么不降价进入医保(量价不平衡),则需花费更多的营销成本去打开市场。

(4)医保谈判完成后,政府(医保部门)将获得社会效益(患者的药物可及性提高、有利于社会的稳定)和经济效益(医疗费用和医保基金支出降低、医保基金利用效率提高)。

(5)医保谈判药品落地,可能存在两种情况:一是药品销量得以提升,“量价平衡”;二是药企没有获得预期市场份额,利润下滑。

1.3 非合作博弈基本假设

(1)参与者:医保部门、医药企业(完全理性)。

(2)策略选择:医保部门——增加高值药品支出;不增加高值药品支出。医药企业——降低药品价格进入医保;不降价进入医保。

(3)假设医保谈判前,药品价格为P,市场份额为Q,药企收益为U;创新药降价进入医保,药品价格为$P_{-1}$,预期获得市场份额为$Q_{+1}$,药企收益为$U_1$;创新药不降价进入医保,药品价格为P,预期获得市场份额为$Q_{-1}$,药企收益为$U_2$,需要花费更多的营销成本($-C_1$),但可视情况借助慈善赠药、授权仿制等方式扩大市场份额获得额外收益(E)。其中,$P_{-1}<P$,$Q_{-1}<Q_{+1}$。

(4)假设医保部门测算出的医保基金总额为T,医保部门增加高值药品支出,虽然短期内需要承担高昂药价及医疗费用对基金池冲击的风险($-C_2$),但能够治疗大量适应症患者,从而减少未来患者数量,并且促进医药企业创新,收获一定社会效益($B_1$);医保部门不增加高值药品支出,患者需要花费额外的医疗费用,患者可能减少未来对医保的投入,造成医保基金的损失($-C_3$),医药企业对创新药进入医保的积极性下降,社会效益降低($-B_2$)。

(5)假设α为对降价进入医保企业的奖励系数(意味着医药企业获得抢占更多市场份额的机会),β为对不降价进入医保企业的惩罚系数(意味着医药企业失去抢占更多市场份额的机会)。

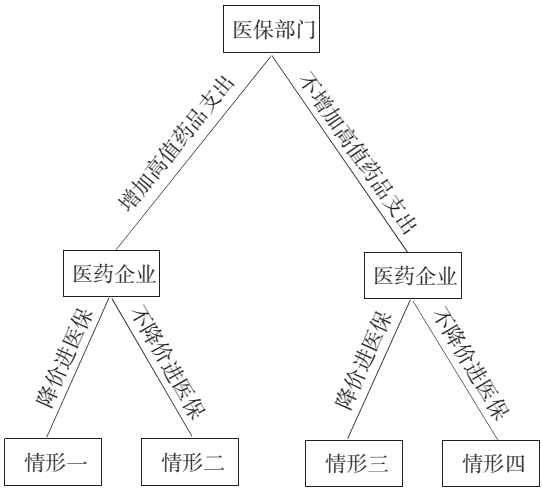



图1 医保部门-医药企业非合作博弈模型

情形一:医保部门选择增加高值药品支出,创新药降价进入医保,医保部门的收益为$T+B_1-C_2-U_1(1+\alpha)$,医药企业的收益为$U_1(1+\alpha)$。

情形二:医保部门选择增加高值药品支出,创新药不降价进入医保,医保部门的收益为$T+B_1-C_2-C_3$,医药企业的收益为$U_2(1-\beta)+E-C_1$。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

情形三:医保部门选择不增加高值药品支出,创新药降价进入医保,医保部门的收益为$T-B_2-C_3-U_1(1+\alpha)$,医药企业的收益为$U_1(1+\alpha)$。

情形四:医保部门选择不增加高值药品支出,创新药不降价进入医保,医保部门的收益为$T-B_2-C_3$,医药企业的收益为$U_2(1-\beta)-C_1$。

根据以上假设和相关变量,得出医保部门和医药企业双方不同策略组合的收益矩阵(见表1)。

**表1 医保部门与医药企业的收益矩阵**

| 策略 | | | 医药企业 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | q | 1-q |
| | | | 降价进入医保 | 不降价进入医保 |
| 医保部门 | p | 增加高值药品支出 | $T+B_1-C_2-U_1(1+\alpha)$, $U_1(1+\alpha)$ | $T+B_1-C_2-C_3$, $U_2(1-\beta)+E-C_1$ |
| | 1-p | 不增加高值药品支出 | $T-B_2-C_3-U_1(1+\alpha)$, $U_1(1+\alpha)$ | $T-B_2-C_3$, $U_2(1-\beta)-C_1$ |

## 2 博弈矩阵分析

在收益矩阵(见表1)中,由于医药企业对高值药品的定价会充分考虑营销成本,并且会想尽办法开拓市场,使自身利益最大化,所以$C_1<E$。当$B_1+B_2\leqslant C_2$时,即:医保部门因增加高值药品支出而导致医保基金风险过高时,得到纳什均衡解:医保部门不增加高值药品支出,医药企业不降价进入医保,患者需要支付额外的医疗费用。这显然会造成谈判失败,不符合医保谈判制度初衷。那么,可以考虑减小$C_2$和增大$\beta$,即一方面要降低医保基金风险,另一方面要提高对不降价进入医保企业的惩罚系数(意味着医药企业无法获得抢占更多市场份额的机会)。

当$B_1+B_2>C_2$时,医保部门增加高值药品支出和医药企业不降价进入医保的博弈不存在纳什均衡解。

假设医保部门以一定的概率p来增加高值药品支出,则不增加高值药品支出的概率就是1-p;医药企业以一定的概率q选择降价进入医保,则选择不降价进入医保的概率为1-q。医保部门用h表示,医药企业用s表示,可得出混合策略下医保部门与医药企业的期望效用函数。

医保部门的期望效用函数为:

$$\begin{aligned}E_h&=p\{q[T+B_1-C_2-U_1(1+\alpha)]+(1-q)(T+B_1-C_2-C_3)\}\\&+(1-p)\{q[T-B_2-C_3-U_1(1+\alpha)]+(1-q)(T-B_2-C_3)\}\\&=p[T+B_1-C_2+C_3(1-q)-qU_1(1+\alpha)]\\&+(1-p)[T-B_2-C_3-qU_1(1+\alpha)]\\&=p[C_3(2-q)+2B_1-C_2]+T-B_1-C_3-qU_1(1+\alpha)\end{aligned}\quad\text{公式(1)}$$

为使医保部门期望效用最大化,对p求偏导,得出医保部门最优化一阶条件为:

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_h}{\partial p}&=p[C_3(2-q)+2B_1-C_2]+T-B_1-C_3-qU_1(1+\alpha)\\&=C_3(2-q)+2B_1-C_2=0\end{aligned}\quad\text{公式(2)}$$

$$q^*=2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}\quad\text{公式(3)}$$

$q^*$的含义为如果医药企业选择不降价进入医保的概率低于$2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$,那么医保部门的最优选择是不增加高值药品支出;如果医药企业选择不降价进入医保的概率高于$2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$,那么医保部门的最优选择是增加高值药品支出;如果医药企业选择不降价进入医保的概率恰好等于$2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$,那么医保部门可以随机选择是否增加高值药品支出。

医药企业的期望效用函数为:

$$\begin{aligned}E_s&=q\{p[U_1(1+\alpha)]+(1-p)[U_1(1+\alpha)]\}\\&+(1-q)\{p[U_2(1-\beta)+E-C_1]+(1-p)[U_2(1-\beta)-C_1]\}\\&=qU_1(1+\alpha)+(1-q)[U_2(1-\beta)+pE-C_1]\\&=q[U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)-pE+C_1]+U_2(1-\beta)+pE-C_1\end{aligned}\quad\text{公式(4)}$$

为使医药企业期望效用最大化,对q求偏导,得出医药企业最优化一阶条件为:

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_s}{\partial q}&=q[U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)-pE+C_1]+U_2(1-\beta)+pE-C_1\\&=U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)-pE+C_1=0\end{aligned}\quad\text{公式(5)}$$

$$p^*=\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}\quad\text{公式(6)}$$

$p^*$的含义为如果医保部门选择增加高值药品支出的概率低于$\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$,那么医药企业的最优选择是不降价进入医保;如果医保部门选择增加高值药品支出的概率高于$\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$,那么医药企业的最优选择是降价进入医保;如果医保部门增加高值药品支出的概率等于$\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$,那么医药企业可随机选择降价进入医保或不降价进入医保。

因此,医保部门和医药企业博弈的混合策略均衡解为:$q^*=2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$,$p^*=\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$,即医药企业以$2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$的概率选择不降价进入医保,在市场上提供高价药品,医保部门则以$\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$的概率增加高值药品支出。

## 3 创新药医保谈判过程的博弈

### 3.1 动态博弈基本假设

(1)在医保谈判过程中,企业报价的博弈类似于罗宾斯泰林讨价还价模型,假设医保基金总额对某一高值药品的支出范围固定为100,医保部门据此与医药企业



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

协商医保支付标准等内容。在给定的谈判协商时间内，第一轮报价，医药企业提出一个价格方案，医保部门同意即进入磋商(还有降价空间)，若不同意，则医保部门说明期望并等待医药企业第二轮报价，医药企业可选择接受医保部门的建议或进行第二轮报价；在第二轮报价中，医药企业提出第二个价格方案，医保部门根据“密封底价”确认第二个价格方案是否进入谈判底价的115%范围内，进入则接受，没有进入则拒绝，谈判终止。

(2)假设医药企业与医保部门在两轮报价过程中存在医保基金消耗，其消耗系数为$\delta(0<\delta<1)$。

(3)为简化模型，假设医药企业和医保部门不能从拒绝对方的方案中获得更多收益，则会接受对方的提案。

(4)策略选择：

医保部门——坚持“密封底价”；不坚持“密封底价”

医药企业——第一次报价降低部分价格，第二次报价在第一次报价基础上进一步降低价格

3.2 模型构建及分析

根据双方的策略选择，分为两种情形。

情形一：医保部门不坚持“密封底价”，企业第一轮报价被医保部门接受，直接进入磋商阶段，企业获得的收益为100，与实际情况不符。

情形二：医保谈判过程包括两轮报价三个阶段(见图2)。

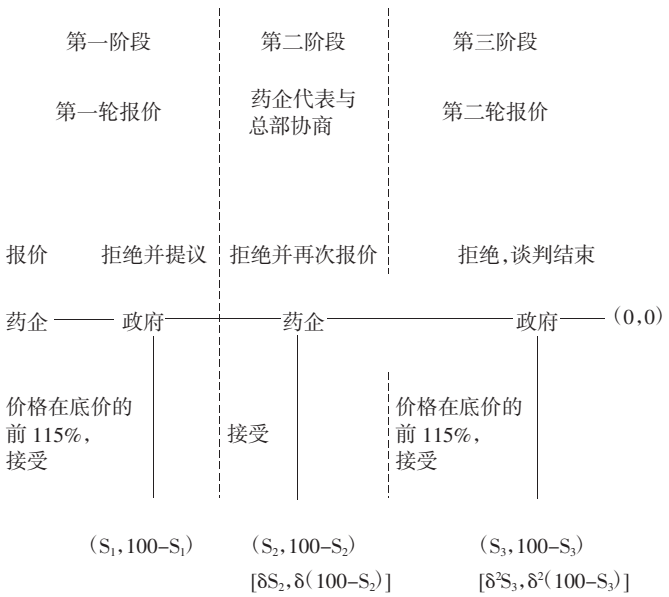



图2 医保谈判讨价还价模型

使用逆向归纳法求解动态博弈的子博弈纳什均衡。

第三阶段(第二轮报价)：由于$\delta^2(100-S_3)\geqslant 0$，并且$Max\delta^2 S_3$，可以求解得出$S_3=100$。

第二阶段(药企代表与总部协商)：由于$\delta S_2\geqslant 100\delta^2$，并且$Max\delta(100-S_2)$，可以求解得出$S_2=100\delta$。

第一阶段(第一轮报价)：由于$100-S_1\geqslant\delta(100-100\delta)$，并且$MaxS_1$，推导得出$S_1\leqslant 100(1-\delta+\delta^2)$，进一步得出，$S_1=100(1-\delta+\delta^2)$，结果为$[100(1-\delta+\delta^2),100(\delta-\delta^2)]$。

图3、图4分别为结果$[100(1-\delta+\delta^2),100(\delta-\delta^2)]$的函数图像，在这一博弈过程中，医药企业作为最后提出价格方案的一方，如果报价被医保部门接受，则谈判成功后收益会更大。

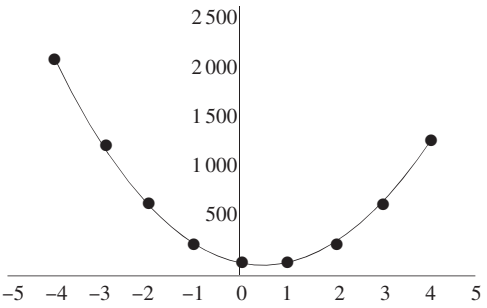



图3 结果$100(1-\delta+\delta^2)$的函数图像

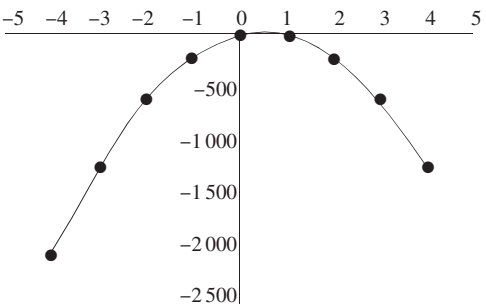



图4 结果$100(\delta-\delta^2)$的函数图像

3.3 2022年医保谈判博弈分析

根据《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(2022年)》，2022年国家药品目录调整分为准备(5—6月)、申报(7—8月)、专家评审(8月)、谈判(9—10月)、公布结果(11月) 5个阶段，涉及药物价格测算评估、基金测算、药物经济学等方法的开展，以及现场谈判/竞价，进而确定全国统一医保支付标准。根据国家医保局2023年发布的数据，有147个目录外药品参与谈判/竞价(含原目录内药品续约谈判)，其中121个药品谈判/竞价成功，总体成功率达82.3%；有24个国产重大创新药纳入谈判，其中20个药品谈判成功，谈判成功率达83.3%(部分谈判成功药品见表2)；2021—2022年，共计47个国产重大创新药参加国家医保谈判，42个谈判成功，成功率达90%，远超普通药品谈判成功率。相比2020年、2021年创新药进入国家基本医保药品目录情况，国家医保局有目的地加大对创新药的支出，促进医药产业的创新发展，同时更好地惠及难治疗或医药可及性较差的众多患者，提高了医保基金的支付效率。



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2 2020年、2021年进入医保目录的代表性创新药

| 项目 | 替雷利珠单抗 | 信迪利单抗、特瑞普利单抗 | 奥布替尼 | 维迪西妥单抗 |
|---|---|---|---|---|
| 靶点 | PD-1 | PD-1 | BTK | HER2ADC |
| 谈判适应症 | HL、UC | 鳞状/非鳞状NSCLC、HCC | MCL、CLL/SLL | 胃癌三线 |
| 医保前单价 | 10 688元/100mg | 2 180元/100mg | 7 196元/盒 | 13 500元/60mg |
| 医保前年费用 | 36万元 | 7.4万元 | 25.9万元 | 87.8万元 |
| 医保后单价 | 2 180元/100mg | 1 450元/100mg | 3 560.4元/盒 | 3 800元/60mg |
| 医保后年费用 | 7.4万元 | 4.9万元 | 12.8万元 | 24.7万元 |
| 降幅 | 80% | 33% | 51% | 72% |
| 患者数量 | HL约1万人<br>UC约11万人 | NSCLC约65万人<br>HCC约38万人 | MCL约2 700人<br>CLL/SLL约7 000人 | 胃癌约46万人 |
| 同靶点竞品 | 2020同年,4款国产PD-1均进入医保 | 2021同年,信达与君实PD-1均参与谈判,覆盖适应症相似 | 与伊布替尼和泽布替尼适应症相同，二者获批时间早于奥布替尼且已经纳入医保 | Roche进口恩美曲妥珠单抗于2020年获批上市,但无胃癌布局且未进医保 |

数据来源:国家医保局。

## 4 结论与建议

### 4.1 博弈模型分析结果

医保部门和医药企业之间药价谈判博弈的纳什均衡解为$[100(1-\delta+\delta^2),100(\delta-\delta^2)]$,在动态博弈过程中,医药企业作为最后提出价格方案的一方,如果报价被医保部门接受,则谈判成功后收益会更大。医保谈判的推行,有利于实现多方共赢。

关于创新药是否进入医保，医保部门和医药企业之间非合作博弈的混合策略均衡解为$q^*=2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$,$p^*=\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$,即医药企业以$2-\frac{C_2-2B_1}{C_3}$的概率选择不降价进入医保,在市场上提供高价药品,医保部门就会以$\frac{U_1(1+\alpha)-U_2(1-\beta)+C_1}{E}$的概率增加高值药品支出。可见，博弈双方的行为与$U_1$、$U_2$、$B_1$、$C_1$、$C_2$、$C_3$、$E$、$\alpha$、$\beta$的大小有关,为使医药企业选择不降价进入医保的概率降低,就要降低$C_2$和增大$\alpha$、$\beta$,即:要提升医药企业选择降价进入医保的概率,就要在增加高值药品支出的同时,减少额外的资源配置成本、降低高昂药价和医疗费用对医保基金的风险冲击,还要加大奖惩系数。具体来说,医保部门要提高管理水平,对医保基金和创新药价值进行科学合理测算,“降本增效”,在“保基本”的同时,重视创新药的医保纳入问题。除此之外,还要构建有效的激励约束机制,提升创新药企业主动降价进入医保的积极性。

### 4.2 对策建议

(1)以药物临床价值为导向,兼顾创新性为原则,完善医保谈判政策及配套机制。2017年开始，国家在医保药品报销决策中引入了卫生技术评估(HTA)方法,但缺乏实际的应用。一方面,我国HTA尚处于从学术研究转向决策实践的阶段,缺少相应的技术指南规范和HTA人力资源;另一方面,用于评估药品创新性、安全性、有效性的真实世界数据搜集存在一定的困难,造成信息不对称。对此,要推进HTA体系和能力的建设,更好地平衡各方利益诉求。同时,构建完善多层次医疗保障体系,发挥政策的协同作用。另外,创新药定价方面可借鉴发达国家自主定价机制,允许企业在一定时间内自主定价。

(2)构建医药信息互联共享平台,减少信息不对称,提高透明度。价格谈判的本质是不完全信息博弈,获得更多的数据和信息支持去击穿“密封价”是医保谈判成功的关键。对此,要加强全国统一医药信息平台建设,及时收录观测药品申报品种、价格、疗效等信息,以及患者就诊、医疗机构处方和企业相关资质、信用记录等信息,减少谈判双方信息不对称，使谈判过程更加公平公开。同时,还可通过线上医保结算,整合医药物流、信息流、资金流,追溯药品购入渠道、资金来源等,使参与谈判的主体更加公开透明;公众亦可及时获取药品价格变动、质量等信息,明确医保支付标准。

(3)医保谈判应坚持医保部门的主体地位,药企次之,其他主体为辅,整合多元价值诉求,强化监督约束。药品谈判采购涉及的利益主体多元,因此要逐渐由政府统一主导转变为以政府为主导、多方共同参与模式。医保部门要继续梳理医保谈判运行逻辑，细化谈判规则,明确各方主体的权利义务,畅通意见反馈渠道,以适当的比例吸纳不同群体参与卫生技术评估流程、医保谈判的民意调查。同时,重视谈判药品购销环节,建立统一信息服务平台,健全监督问责机制,强化各方监督制约作用,推动谈判药品成功落地。最后,继续探索谈判失败药品再申诉或重新谈判的机制，提升谈判决策的科学性。2023年7月21号发布的《谈判药品续约规则》新增“在续约触发降价机制时,可以申请以重新谈判的方式续约”的规定,以此增强企业信心。对药企而言,要提供高品质创新药参与谈判,最好为独家创新药,形成谈判优势;提供真实且充分的用药成本、生产能力、销量、市场占有率等

(下转第15页)



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[14] Lawlor R,Wilsdon T,Darquennes E,et al.Accelerating patient access to oncology medicines with multiple indications in Europe [J].*J Mark Access Health Policy*,2021,9(01):1964791.
[15] F Verbeek,C van Gils, R Heine,et al.One size does not fit all: calculating the cost-effectiveness of multiple indications of pembrolizumab in the netherlands[J]. *Value in Health*,2022,25(12):S9.
[16] Neri M,Towse A,Garau M.Multi-Indication Pricing(MIP): Practical solutions and steps to move forward[R].London:Office of Health Economics,2018.
[17] Cole A,Towse A,Lorgelly P,et al.Economics of Innovative Payment Models Compared with Single Pricing of Pharmaceuticals [R].Research Papers,2018.
[18] Víctor Preckler,MSc Jaime Espín.The role of indication-based pricing in future pricing and reimbursement policies:a systematic review[J].*Systematic Literature Review*,2022,25(04):666-675.
[19] Hans P.Binswanger and Vernon W.Ruttan.induced innovation. technology, institutions, and development [J].*The Economic Journa*l,1979,89(354):437-439.
[20] 王樱澄,吴尧,杨岚,等.基于价值的多适应证药品医保准入与定价方法研究[J].中国药房,2023,34(02):179-184.
[21] 刘鹏,张伊静.中国式政策示范效果及其影响因素——基于两个示范城市建设案例的比较研究[J].行政论坛,2020,27(06):65-73.
[22] Wong J,Motulsky A,Abrahamowicz M,et al.Off-label indications for antidepressants in primary care:descriptive study of prescriptions from an indication based electronic prescribing system[J]. *BMJ*,2017,356:j603.
[23] Walker J L.The Diffusion of Innovations among the American States [J].*The American Political Science Review*,1969,63(03):880-899.
[24] 韩晓睿.完整精算法与简易调算法——多适应症药物准入评估方法比较研究[J].中国医疗保险,2022(07):9-14.
[25] 王雯,谭婧,任燕,等.重新认识真实世界数据研究:更新与展望[J].中国循证医学志,2020,20(11):1241-1246.
[26] 印冠锦,张梦阳,吴惠庶,等.真实世界数据相关标准体系研究与应用进展[J].医学信息学杂志,2022,43(06):30-35.
[27] 丁伟.真实世界数据质量提升研究[D].沈阳药科大学,2022.
[28] 李言生,韩士斌,苏明亮,等.医院真实世界数据治理平台建设探索[J].中国卫生信息管理杂志,2022,19(06):925-930.
[29] 徐国冲,翟文康.公共价值是如何被创造出来的?——兼评《创造公共价值:政府战略管理》与 Recognizing Public Value[J].公共行政评论,2021(04):179-188.
[30] 张晓.医保支付的出发点是价值[J].中国医疗保险,2017(11):32.
[31] National Health Council.The patient voice in value:the National Health Council patient-centered value model rubric [EB/OL].(2023-02-13) [2023-11-17].https://nationalhealthcouncil.org/additional-resources/call-for-comments-patient-centered-value-model-rubric-and-get-ready-checklist-for-patient-organizations-2/.
[32] Neumann P J,Garrison L P,Willke R J.The history and future of the "ISPOR Value Flower":addressing limitations of conventional cost-effectiveness analysis[J]. *Value in Health*,2022,25(04):558-565.
[33] 崔鹏磊,李世勇,常峰,等.药品风险分担协议对中国大陆的启示——以澳大利亚、新西兰、中国台湾为例[J].中国卫生政策研究,2017,10(02):21-26.

【收稿日期 2023-11-20】【责任编辑 胡希家】

(上接第9页)

方面的数据,使谈判双方获得充足的药品数据;及时对谈判规则征求意见进行反馈,使谈判规则更合理;最后,干干净净地参与谈判,创建风清气正的谈判环境,在规则下谈判、在阳光下谈判。

(4)强化医药主体责任,充分发挥第三方机构作用。医师和医疗机构可向医保部门和谈判专家反馈进入医保谈判药品的使用情况,包括用药经济性、患者负担、治疗效果、适应症变化、不良反应等,为药物经济学评价提供参考。医师还可作为谈判专家,加入到医保谈判的过程中,以治疗和用药的专业性影响谈判结果。监管部门主要做好药品质量安全和不良反应统计工作,并反馈给医保部门和谈判专家。患者可向医保部门、医疗机构、医师、监管部门反馈谈判药品的经济负担、治疗效果、满意度,也为药物经济学评价和"谈判底价"的确定提供参考。独立的第三方机构既可以辅助监管部门监管,又可以为企业提供合规咨询服务,作为媒介提升医药市场资源配置效率,并向医保部门和谈判专家输送真实数据。

**参考文献**

[1] 刘心怡,张璐莹,陈文.国家谈判准入药品在各地的医保管理政策梳理与分析[J].中国卫生政策研究,2019,12(09):77-81.
[2] 吕兰婷,胡邱锪,郭珉江.我国药品谈判政策演变与创新扩散机制探究[J].中国卫生政策研究,2022,15(09):47-55.
[3] 周尚成.医疗保险谈判博弈模型构建及分析[J].保险研究,2011(12):88-96.
[4] 谭清立,林岱衡.论医保统筹进程中的医保药品目录管理[J].卫生经济研究,2021,38(03):50-52,56.
[5] 张新鑫,侯文华,申成霖.价格管制、医保支付政策与制药企业创新激励[J].科研管理,2015,36(12):120-128.
[6] 谭清立,郭润镒,孙慧琳,等.药品集中带量采购与医保谈判政策的协同作用[J].中国药房,2021,32(15):1793-1799.
[7] Luo Z H,Gyawali B,Han S,et al.Can locally developed me-too drugs aid price negotiation?An example of cancer therapies from China[J].*Seminars in Oncology*,2021,48(02): 141-144.

**作者简介**:谭清立(1987— ),男,博士,副教授,主要研究方向:医疗保障与医药政策。

【收稿日期 2023-11-13】【责任编辑 胡希家】



(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net